18 Carta ao treinador e à escola

Modelo para o pediatra adaptar e enviar com a concordância do adolescente e da família. A versão editável (.docx) acompanha o kit.

[Cidade], [data] [Nome do serviço ou consultório]

Prezado(a) [nome do treinador ou da coordenação],

Acompanho [nome do atleta], de [idade] anos, que treina [modalidade] com vocês. Com a concordância dele e da família, escrevo para combinar cinco cuidados que fazem diferença na saúde e no rendimento de atletas em crescimento.

1. **Comida primeiro.** A necessidade de proteína do adolescente que treina gira em torno de 1,5 g por quilo por dia e pode ser atendida com a alimentação[1]. Especialistas em futebol de base recomendam a mesma abordagem para os jogadores juniores[2].
2. **Suplementos fora da rotina da equipe.** Peço que não indiquem nem distribuam suplementos. No Brasil, a creatina não é autorizada em suplementos para menores de 19 anos[3,4], e já se encontraram substâncias proibidas não declaradas em produtos vendidos como suplementos[5]. Com controle antidopagem, o atleta responde por qualquer substância encontrada, mesmo sem intenção[6].
3. **Sem comentários sobre peso e corpo.** Comentários sobre peso ou aparência podem precipitar ou perpetuar transtornos alimentares em atletas[1]. O Comitê Olímpico Internacional recomenda avaliar composição corporal em menores de 18 anos apenas com finalidade médica[7].
4. **Água à vontade e pausas para beber.** O jovem atleta pode esquecer de beber se ninguém lembrar e continuar se exercitando para acompanhar os colegas[1]. A água deve estar sempre disponível[8].
5. **Avisem a família se notarem** perda de peso, refeições puladas, fraturas por estresse ou outras lesões que se repetem, mudança de humor, mudança rápida do corpo ou uso de produtos para ganhar músculo ou emagrecer[7,9].

Num programa conduzido dentro das próprias equipes, atletas do ensino médio do sexo feminino passaram a iniciar menos o uso de remédios para emagrecer e de substâncias para melhorar o desempenho[10].

Fico à disposição para conversar.

Atenciosamente,

[Nome do pediatra] · Conselho Regional de Medicina (CRM) [número e estado] · [telefone ou e-mail profissional]

FONTES

1. Desbrow B. Youth athlete development and nutrition. Sports Med. 2021;51(Suppl 1):3-12. doi:10.1007/s40279-021-01534-6
2. Collins J, Maughan RJ, Gleeson M, Bilsborough J, Jeukendrup A, Morton JP, et al. UEFA expert group statement on nutrition in elite football. Current evidence to inform practical recommendations and guide future research. Br J Sports Med. 2021;55(8):416. doi:10.1136/bjsports-2019-101961
3. Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Instrução Normativa nº 28, de 26 de julho de 2018. Estabelece as listas de constituintes, de limites de uso, de alegações e de rotulagem complementar dos suplementos alimentares. Diário Oficial da União. 2018 jul 27; Seção 1. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2018/int0028_26_07_2018.pdf
4. Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Instrução Normativa nº 373, de 5 de junho de 2025. Altera a Instrução Normativa nº 28, de 26 de julho de 2018, que estabelece as listas de constituintes, de limites de uso, de alegações e de rotulagem complementar dos suplementos alimentares. Diário Oficial da União. 2025 jun 9; Seção 1.
5. Geyer H, Parr MK, Mareck U, Reinhart U, Schrader Y, Schänzer W. Analysis of non-hormonal nutritional supplements for anabolic-androgenic steroids: results of an international study. Int J Sports Med. 2004;25(2):124-9. doi:10.1055/s-2004-819955
6. Brasil. Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Perguntas frequentes [Internet]. Brasília: ABCD; [citado 2026 out 11]. Disponível em: https://www.gov.br/abcd/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes
7. Mountjoy M, Ackerman KE, Bailey DM, Burke LM, Constantini N, Hackney AC, et al. 2023 International Olympic Committee's (IOC) consensus statement on Relative Energy Deficiency in Sport (REDs). Br J Sports Med. 2023;57(17):1073-97. doi:10.1136/bjsports-2023-106994
8. American Academy of Pediatrics Committee on Nutrition; Council on Sports Medicine and Fitness. Sports drinks and energy drinks for children and adolescents: are they appropriate? Pediatrics. 2011;127(6):1182-9. doi:10.1542/peds.2011-0965
9. LaBotz M, Griesemer BA; Council on Sports Medicine and Fitness. Use of performance-enhancing substances. Pediatrics. 2016;138(1):e20161300. doi:10.1542/peds.2016-1300
10. Elliot DL, Goldberg L, Moe EL, Defrancesco CA, Durham MB, Hix-Small H. Preventing substance use and disordered eating: initial outcomes of the ATHENA (athletes targeting healthy exercise and nutrition alternatives) program. Arch Pediatr Adolesc Med. 2004;158(11):1043-9. doi:10.1001/archpedi.158.11.1043